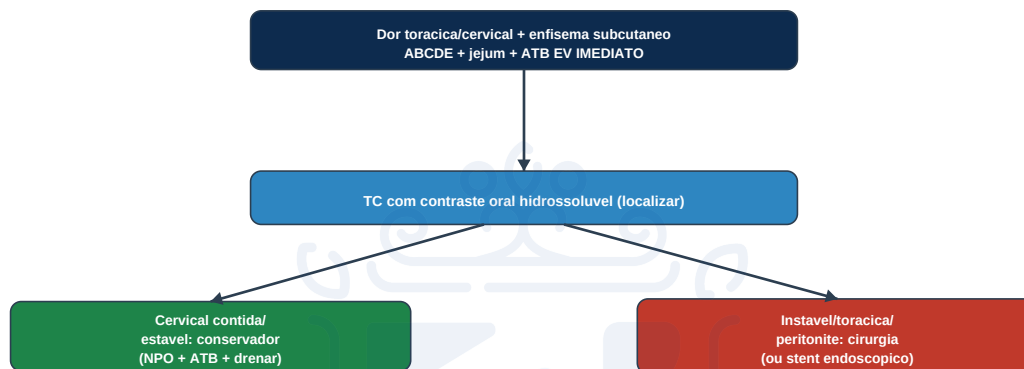


PERFURAÇÃO ESOFÁGICA — ATB + CIRURGIA

FLUXOGRAMA — EMERGÊNCIA TEMPO-DEPENDENTE

PERFURAÇÃO ESOFÁGICA — JEJUM + ATB + IMAGEM + CIRURGIA



DEFINIÇÃO E ETIOLOGIA

EMERGÊNCIA

- Solução de continuidade da parede esofágica com extravasamento para mediastino/pleura/cervical — alto risco de MEDIASTINITE, sepse e morte
- Etiologia: IATROGÊNICA (endoscopia/dilatação — a mais comum hospitalar); espontânea por vômitos (Boerhaave, distal); trauma; corpo estranho/cáustico; neoplasia
- Quadro: dor cervical/torácica/epigástrica súbita e intensa, ENFISEMA subcutâneo (crepitação), dispneia, disfagia/odinofagia
- Evoluído: febre, taquicardia, hipotensão, odor fétido, mediastinite/choque
- Apresentação pode ser INSIDIOSA após procedimentos — alto índice de suspeição

DIAGNÓSTICO

IMAGEM

- RX de tórax: pneumomediastino, enfisema subcutâneo, derrame pleural (frequentemente à esquerda no Boerhaave)
- TC com contraste IV + contraste oral HIDROSSOLÚVEL (Gastrografin): exame de escolha — extravasamento, ar no mediastino, coleções, local/extensão
- Esofagograma com contraste hidrossolúvel se TC inconclusiva (bário só com cautela — risco de mediastinite química)
- EDA com cautela (evitar insuflação excessiva) — por equipe experiente, útil para terapia (stent)
- Labs: hemograma, PCR, função renal, gasometria se instável, hemoculturas x2 se febre

CONDUTA IMEDIATA NO PS

Rx JEJUM + ATB + SUPORTE

ABCDE: via aérea (IOT precoce se comprometimento), O₂, monitorização; 2 acessos calibrosos + reposição volêmica
JEJUM ABSOLUTO; analgesia titulada; corrigir distúrbios hidroeletrólíticos
ATB EV IMEDIATO: Piperacilina-tazobactam 4,5 g EV 6-8/8h (cobre Gram-negativos + anaeróbios + orais)
Alergia grave a beta-lactâmico: Ciprofloxacino 400 mg 12/12h + Metronidazol 500 mg 8/8h
Considerar Fluconazol 200 mg 12/12h em perfuração tardia (> 24h)/imunossuprimido
Pantoprazol 40 mg EV 12/12h; SNG de aspiração suave com cautela (não ultrapassar a perfuração às cegas); drenar derrame pleural significativo

DECISÃO TERAPÊUTICA

Estratégia	Quando
Conservador	Perfuração CERVICAL contida, sem sepse/mediastinite extensa, paciente estável: NPO, ATB EV, vigilância, drenagem percutânea, suporte nutricional
Endoscópico	Stent coberto (selar), clip (pequenas), terapia a vácuo — torácicas/abdominais selecionadas, diagnóstico precoce, bordas viáveis
Cirúrgico	Instabilidade/choque séptico, peritonite, grande extravasamento/mediastinite difusa, falha do conservador/endoscópico
Cirurgia por local	Cervical: drenagem/sutura; Torácica: toracotomia + desbridamento + drenagem; Abdominal: sutura + omento ou esofagectomia/derivação

PONTOS-CHAVE / MODELO DE REGULAÇÃO

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Alta suspeita: vômitos intensos + dor torácica súbita + enfisema subcutâneo (Boerhaave); ou pós-endoscopia (iatrogênica)
- NÃO atrasar ATB e cirurgia/drenagem por busca de imagem se o paciente está instável
- Cervical = melhor prognóstico (mais conservador); torácica/abdominal = maior risco de mediastinite (intervenção agressiva)
- Paciente ____ anos; perfuração ____ (cervical/torácica/abdominal), ____ (precoce < 24h / tardia); enfisema ____; sepse ____.
- Condutas: jejum, ATB ____ às ____, IBP EV, drenagem ____; solicito cirurgia torácica/geral URGENTE + UTI; nutrição por sonda distal/parenteral.

SM24
Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Qual é o exame de imagem de escolha para confirmar e localizar uma perfuração esofágica?

- A) Radiografia simples isolada
- B) TC com contraste IV e contraste oral hidrossolúvel (Gastrografin)
- C) Esofagografia baritada
- D) Ultrassom cervical
- E) Ressonância magnética

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual é a etiologia mais comum de perfuração esofágica no ambiente hospitalar?

- A) Espontânea (Boerhaave)
- B) Iatrogênica (procedimentos endoscópicos/dilatação)
- C) Trauma penetrante
- D) Neoplasia
- E) Corpo estranho

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Qual conduta deve ser iniciada IMEDIATAMENTE diante de suspeita de perfuração esofágica?

- A) Dieta líquida
- B) Jejum absoluto + antibiótico EV de amplo espectro + avaliação cirúrgica e imagem urgente
- C) Alta com IBP oral
- D) Endoscopia com insuflação ampla
- E) Apenas analgesia

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Qual perfuração esofágica tem melhor prognóstico e maior chance de manejo conservador?

- A) Torácica com mediastinite
- B) Cervical contida em paciente estável
- C) Abdominal com peritonite
- D) Qualquer perfuração tardia
- E) Perfuração com choque séptico

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Qual achado clínico/radiológico reforça a suspeita de perfuração esofágica (ex.: Boerhaave)?

- A) Ascite
- B) Enfisema subcutâneo / pneumomediastino, frequentemente com derrame pleural à esquerda
- C) Icterícia
- D) Esplenomegalia
- E) Sopro cardíaco

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

A TC com contraste IV e contraste oral hidrossolúvel (Gastrografin) é o exame de escolha: identifica extravasamento, ar no mediastino, coleções e o local/extensão da perfuração.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

A causa mais comum no ambiente hospitalar é a iatrogênica (procedimentos endoscópicos/dilatação); a espontânea (Boerhaave) é típica por vômitos intensos, na porção distal.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

Toda suspeita exige jejum absoluto, antibiótico EV de amplo espectro imediato, avaliação cirúrgica e imagem urgente — não se deve atrasar o ATB/cirurgia em paciente instável.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

A perfuração cervical contida, em paciente estável, tem melhor prognóstico e maior chance de manejo conservador; torácicas/abdominais têm maior risco de mediastinite e costumam exigir intervenção.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

Enfisema subcutâneo e pneumomediastino (com derrame pleural frequentemente à esquerda no Boerhaave) reforçam a suspeita de perfuração esofágica.

SM24
Suporte ao Plantão Médico